

CISTITE INTERSTICIAL

FERNANDO NESTOR FACIO JUNIOR
FÁBIO AUGUSTO VASILCEAC
LUIS FRANCISCO BARBERO GABRIOTTI
LUIS CESAR FAVA SPESSOTO

■ INTRODUÇÃO

Cistite intersticial (CI) é uma das múltiplas formas da síndrome de **dor pélvica crônica**. Sua etiologia não é totalmente definida, o que a diferencia dos **demais tipos** de cistite, que podem ser:¹

- infecciosa (causada pelas bactérias que comumente causam infecção do trato urinário, principalmente *E. coli*);
- actínica (radioterapia); ou
- idiopática (intersticial).

O termo *cistite intersticial*, que remete à síndrome caracterizada por queixa de dor suprapúbica, alteração na frequência urinária, urgência miccional combinada a processo inflamatório da bexiga, foi descrita principalmente por Guy Hunner em 1915, associada a áreas de hiperemia na bexiga visualizadas à cistoscopia. As lesões vesicais foram então denominadas **úlceras de Hunner**.



Atualmente, o termo **síndrome da bexiga dolorosa** (SBD),¹ utilizado pela primeira vez na International Continence Society (2002), foi defendido pela European Society for the Study of Interstitial Cystitis (2008)² para a queixa de dor supra púbica e/ou desconforto vesical associada à frequência e/ou urgência miccional, na ausência de outras patologias do sistema urinário inferior, como infecção do trato urinário, litíase urinária, neoplasia urotelial, entre outras.³

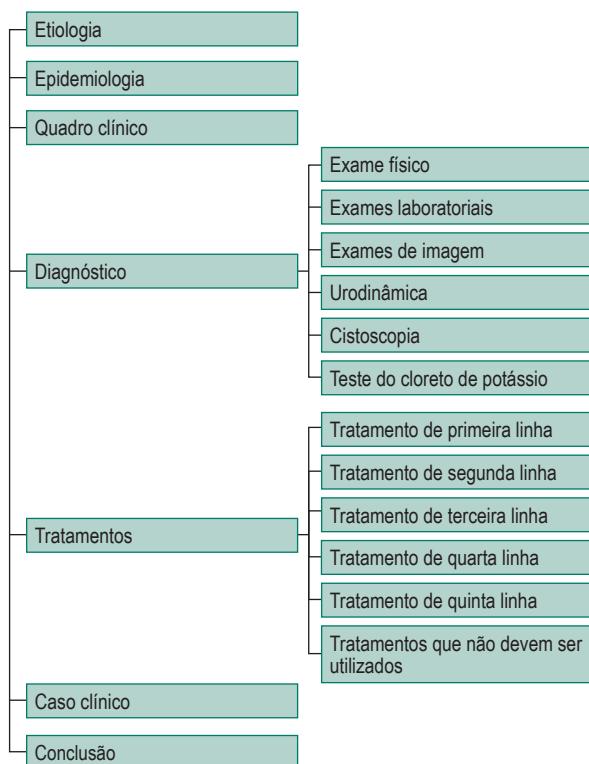
A CI é uma doença de **difícil definição e diagnóstico**. Sua caracterização de baseia nas características clínicas, pois não há marcadores específicos, sendo os exames complementares para exclusão de outras patologias que mimetizam o quadro clínico.³

■ OBJETIVOS

Ao final da leitura deste artigo, o leitor será capaz de:

- suspeitar de CI/SBD mediante ao amplo e inespecífico quadro clínico apresentado;
- estar ciente de que o diagnóstico não é específico e sim por exclusão de outras patologias;
- conhecer as opções de tratamento para o CI/SBD.

■ ESQUEMA CONCEITUAL



■ ETIOLOGIA



LEMBRAR

Não totalmente definida, há atualmente algumas **hipóteses** a respeito da CI, que, possivelmente, não apresenta uma única etiologia isolada, mas sim uma **associação** delas. Estuda-se a ativação dos **mastócitos** na **camada urotelial** (camada de revestimento da mucosa vesical), sendo o fator de tal ativação o desencadeador da patologia.



Outra hipótese, muito aceita, refere que áreas com **lesões** presentes no **urotélío** alteram a permeabilidade deste, conferindo processo **inflamatório**, com danos à camada de **glicosaminoglicanos** (GAGs),⁴ substância que protege o urotélío, promovendo danos teciduais por agentes da própria urina. Essa hipótese também foi reforçada com a descoberta do **fator antiproliferativo**, que, após a lesão presente no urotélío, impede o reparo das GAGs, podendo inclusive ser um futuro marcador da doença, visto que ele não está presente na urina nas demais patologias vesicais.⁵

Discute-se também se a CI é um **sintoma** de **outras patologias** que frequentemente estão associadas à ela a a SBD, não apenas uma patologia isolada. Entre elas as mais comuns são:⁴

- ansiedade;
- fibromialgia;
- síndrome do pânico;
- traumas pélvicos;
- algumas doenças autoimunes.

■ EPIDEMIOLOGIA

A epidemiologia da CI é muito variada, pois os estudos que abordam a incidência da CI/SBD o fazem com diferentes métodos e, principalmente, por diferentes tipos de questionários, que envolvem o paciente com seus sintomas, diagnóstico prévio e estudos retrospectivos com avaliação de prontuários. Os mais significativos, orientam que a patologia incide mais no sexo feminino, 300/100.000, e 30-60/100.000 para o sexo masculino.⁶

■ QUADRO CLÍNICO



Em se tratando do quadro clínico, há **grande variação** de sintomas e de intensidade e duração dos mesmos, com **tempo médio** de **2 anos** para a evolução de 1 único sintoma para todo o complexo que caracteriza a CI/SBD:⁶

- **dor** é o sintoma mais comum, atingindo quase todos os pacientes. Ela é referida como suprapúbica, piora ao enchimento vesical, associada a certos tipos de alimentos/bebidas, e frequência urinária; pode ser irradiada a demais órgãos ou estruturas pélvicas;⁷
- **infecção de trato urinário** sempre deve ser pesquisada, podendo ser positiva e negativa nos demais exames de urocultura;⁷
- **frequência urinária aumentada** pode ocorrer em até 92%. Já a **urgência miccional** pode ocorrer em até 84%. Esses sintomas devem ser muito bem questionados ao paciente, pois podem existir intencionalmente, uma vez que a micção com intervalo curto pode ser um mecanismo de defesa para evitar a dor e até a incontinência urinária de uma bexiga hiperativa;⁸
- distúrbios sexuais como **dispareunia** em mulheres e **dor à ejaculação** nos homens também podem ocorrer, piorando muito a qualidade de vida física e mental dos pacientes;⁷
- outros sintomas relacionados a outras síndromes pode ser referidos devido à grande frequência delas com CI/SBD, como síndrome do pânico, síndrome do cólon irritável, fibromialgia, ansiedade, entre outras.⁹

■ DIAGNÓSTICO

Não há exame específico para a CI. O arsenal diagnóstico é realizado principalmente para **exclusão** de outras patologias. O quadro clínico sugestivo, com exames que não diagnosticam outras patologias, é que sugere CI/SBD.¹⁰



Os critérios diagnósticos são apresentados no Quadro 1, descritos pela National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) de 1990. Tais critérios, associados aos **exames complementares**, sugerem o diagnóstico.¹¹

Quadro 1

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS	
Sugere	■ Glomerulações após hidrodistensão ■ Úlcera de Hunner ■ Dor suprapúbica e alteração da frequência
Não sugere	■ Capacidade vesical > 350mL em cistometria ■ Ausência de urgência na cistometria com 150mL ■ Demonstrações de contrações involuntárias no detrusor ■ Sintomas que duram menos do que 9 meses ■ Ausência de noctúria ■ Alívio de sintomas com antibióticos, antissépticos, anticolinérgicos e antiespasmódicos ■ Frequência urinária diurna menor do que 8 vezes ■ Cistite, litíase uretral ou vesical/prostatite bacteriana nos últimos 3 meses ■ Herpes genital ativo ■ Câncer ginecológico ■ Divertículo uretral ■ Cistite química ■ Tuberculose urinária ■ Cistite actínia ■ Tumor vesical ■ Vaginite ■ Menores de 18 anos

Fonte: Sacomani (2013).¹¹

EXAME FÍSICO

O exame físico serve para descartar **outras patologias**, como distopias genitais, vulvovaginites e patologias uretrais nas mulheres, processo inflamatório prostático/perineal nos homens e alterações neurológicas em ambos.²

EXAMES LABORATORIAIS

Dos exames laboratoriais, são válidos, principalmente, **urina tipo I** e **urocultura**, que não devem indicar processo infeccioso.



É importante, também, a avaliação de distúrbios renais investigados.²

EXAMES DE IMAGEM

Os exames de imagem são importantes para afastar patologias como litíase urinária, neoplasias, variações anatômicas, entre outras. Pode-se iniciar com ultrassonografia dos rins e das vias urinárias e, se houver dúvida ou necessidade de confirmação diagnóstica, continuar investigação com tomografia computadorizada ou ressonância magnética, dependendo da função renal e/ou história prévia de alergia ao contraste.²

URODINÂMICA

Autores divergem se deve ser realizada urodinâmica de rotina ou não. Sua importância se deve ao fato de poder determinar a capacidade vesical e sua relação com a dor/micção, presença de contratilidade detrusora involuntária (que pode causar dor), fluxos miccionais, pressões vesicais e perda urinária.



Urodinâmica deve ser indicada em casos de **exceção**, após avaliação prévia de um especialista em urologia.¹²

CISTOSCOPIA

Também realizada com fins de **exclusão**, a cistoscopia possibilita a avaliação de glomerulações/inflamações da mucosa vesical, visualização de úlceras de Hunner e também da capacidade vesical, presença de corpo estranho, cálculos urinários, neoplasia, divertículos, alterações uretrais.



Biópsia vesical deve ser realizada durante a cistoscopia em casos suspeitos, que podem determinar neoplasia, processos inflamatórios e/ou infecciosos, tuberculose vesical, sendo, portanto, também um artifício para exclusão de demais patologias.²

TESTE DO CLORETO DE POTÁSSIO

Após instilação de KCl intravesical, há intensa dor vesical. Antigamente muito utilizado, atualmente está em **desuso**, pois o índice de **falso-positivo** pode chegar a 36%.¹³

■ TRATAMENTOS

Assim como a etiologia e a fisiopatologia da CI/SBD não são totalmente elucidadas, o tratamento, por consequência, também não é específico, visando principalmente a **melhora clínica** e da **qualidade de vida**.

Inicialmente, o paciente deve ser **orientado** sobre a patologia, seu caráter crônico, a fisiologia vesical e certas mudanças de comportamento que eventualmente podem melhorar o quadro, como ingesta hídrica, micção, bem como a correlação dos sintomas com *stress* que podem piorar os sintomas, certos tipos de alimentos e substâncias que eventualmente podem piorar o quadro e, principalmente, que o tratamento é de **longo prazo**.¹⁴

TRATAMENTO DE PRIMEIRA LINHA

O tratamento de primeira linha baseia-se em **analgesia**. Dificilmente, os analgésicos proporcionarão remissão completa do quadro algico, mesmo os opioides. Porém, proporcionam melhora dos sintomas e na qualidade de vida.¹⁵

TRATAMENTO DE SEGUNDA LINHA



No tratamento de segunda linha, utilizamos **antidepressivos tricíclicos e antialérgicos**:

- **amitriptilina** em doses de 25mg a 100mg ao dia, com melhora da dor e urgência miccional. Os principais efeitos colaterais são sonolência e náuseas (grau de recomendação [GR] B);
- **hidroxizina** na dose de 10mg a 75mg, 1 vez ao dia com poucos efeitos colaterais, como fraqueza e discreta sonolência (GR D);
- **gabapentina**: anticonvulsivante com bons resultados em quadros de dor crônica;
- **pentosan polissulfato** na dose de 100mg, 3 vezes ao dia, com baixa incidência de efeitos colaterais, apresenta melhora da dor, urgência e frequência (GR B).

TRATAMENTO DE TERCEIRA LINHA



O tratamento de terceira linha é conduzido com medicamentos **intravesicais**, que agem diretamente na mucosa vesical, com menor ação sistêmica e efeitos colaterais das medicações orais. São eles:

- **dimetilsulfóxido (DMSO)**: instilação vesical quinzenal de 50mL na concentração de 50% com retenção na bexiga por 15 minutos. Depois de 4 aplicações, espaçar o tratamento. Diminui a inflamação e a dor, relaxa a musculatura (GR B);
- **heparina** com esquemas descritos variando de 10 mil a 40 mil UI diluídos em 10mL de água destilada até 3 vezes por semana. Na teoria, reconstitui a camada de GAGs (GR C);
- **lidocaína**: utilizada em associação com heparina ou triancinolona (GR C);
- **cistoscopia** sob anestesia (sedação – geral endovenosa) realizando hidrodilatação de curta duração (10 minutos) e com baixa pressão (60 a 80cm de H₂O). Se for encontrada úlcera de Hunner, realizar a cauterização do local (*laser* ou eletrocautério) ou injeção de triancinolona (GR C);
- **neuromodulação**: realizar o teste de neuroestimulação; se houver melhora, proceder a implante definitivo do estimulador (GR C).

TRATAMENTO DE QUARTA LINHA

O tratamento de quarta linha é realizado com **imunossupressores**, embora não haja consenso. Deve ser bem discutido com o paciente, devido a efeitos adversos e custo do tratamento.



Ciclosporina A ou **toxina botulínica tipo A** podem ser administradas se outros tratamentos não foram eficientes e o paciente aceitar, lembrando a possibilidade dele necessitar de cateterismo intermitente após injeção da toxina. (GR C)

TRATAMENTO DE QUINTA LINHA

O tratamento de quarta linha consiste em procedimentos **cirúrgicos**, sendo indicado somente em casos graves, refratários, em que houve acentuada debilidade do paciente, com intuito de melhora da qualidade de vida. Nesses casos, há indicação de **cistoplastia** ou **derivação urinária** (GR C).



ATIVIDADE

1. Elabore um fluxograma de atendimento para a cistite intersticial. Compare sua resposta com a Figura 1, a seguir.



A Figura 1 mostra o fluxograma de tratamento para a cistite intersticial.

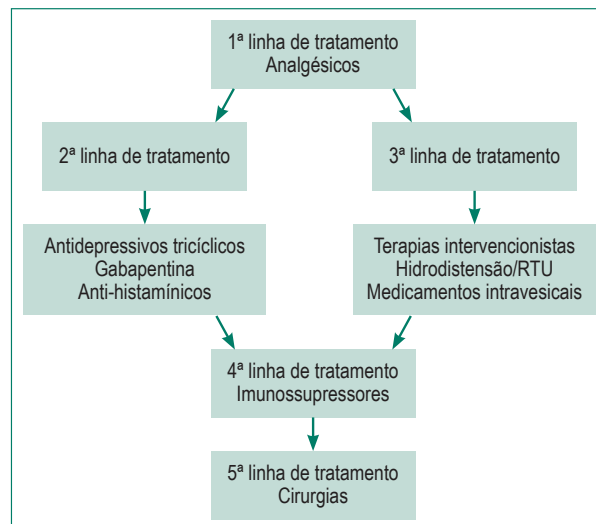


Figura 1 – Fluxograma de tratamento para a CI/SBD.
Fonte: Sacomani (2013).¹¹

TRATAMENTOS QUE NÃO DEVEM SER UTILIZADOS

Entre os tratamentos que não devem ser instituídos no manejo da cistite intersticial estão:

- antibioticoterapia de longa duração;
- BCG (bacilo de Calmette e Guérin) intravesical;
- hidrodistensão de longa duração com alta pressão.



ATIVIDADE

2. Pode-se definir a causa bem estabelecida da cistite intersticial, que é:

- A) bacteriana.
- B) fúngica.
- C) viral.
- D) Nenhuma das respostas está correta.

Resposta no final do artigo

3. Quanto à epidemiologia da cistite intersticial, pode-se afirmar que:

- A) afeta mais o sexo feminino.
- B) atinge principalmente homens com comportamento sexual promíscuo.
- C) afeta principalmente crianças até 2 anos de idade.
- D) ocorre em usuário crônicos de drogas ilícitas.

Resposta no final do artigo

4. Qual o principal exame a ser realizado na suspeita clínica da cistite intersticial?

- A) FAN.
- B) Creatinina.
- C) Urina 1 com cultura.
- D) Proteinúria em urina de 24 horas.

Resposta no final do artigo

5. Constituem exames para afastar outras patologias que mimetizam o quadro clínico da cistite intersticial:

- I. US rins e vias urinárias.
- II. cistoscopia.
- III. urodinâmica.
- IV. biópsia renal.

Quais indicações estão corretas?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.

Resposta no final do artigo

6. São medicamentos considerados no tratamento de cistite intersticial:

- I. amitriptilina.
- II. antibioticoterapia de longa duração.
- III. cimetidina.
- IV. gabapentina.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.

Resposta no final do artigo

7. São medicamentos intravesicais que podem ser utilizados para tratamento de cistite intersticial:

- I. BCG.
- II. heparina.
- III. dimetilsulfóxido (DMSO).
- IV. lidocaína.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.

Resposta no final do artigo

8. A descrição de úlceras de Hunner durante uma cistoscopia remete à:

- A) litíase vesical.
- B) tuberculose vesical.
- C) cistite intersticial.
- D) neoplasia vesical.

Resposta no final do artigo

■ CASO CLÍNICO



Mulher, branca, 56 anos, refere quadro de **disúria**, há cerca de 6 meses. Também relata que nas últimas semanas iniciou quadro de frequência urinária alterada, com urgência miccional e polaciúria. Nega febre no período. Nega alteração da coloração ou do cheiro da urina. Refere ingesta hídrica de 2,5 litros de água/dia. Quadro de infecção do trato urinário (ITU) esporádica, última vez há 5 anos. Fez uso de antibioticoterapia há 30 dias, com término da medicação há 15 dias. Sem orientação médica, pegou a medicação de uma conhecida que havia feito tratamento para ITU. Não houve melhora do quadro. Nega hematúria associada. Refere história prévia de nefrolitíase em exames de rotina há cerca de 15 anos, porém nunca necessitou de cirurgia e/ou internação hospitalar. Antecedentes pessoais: HAS controlada em uso de captopril 25mg 12/12 horas; ansiedade em uso de fluoxetina 25mg/dia; tabagista de longa data 1 maço/dia.



ATIVIDADE

9. Quais exames iniciais você solicitaria para essa paciente?

.....

.....

.....

.....

Resposta no final do artigo

10. Diante da normalidade dos exames solicitados na questão anterior, e com manutenção dos sintomas, como você prossegue a investigação e como explicaria à paciente o resultado dos exames?

.....

.....

.....

.....

Resposta no final do artigo

11. Diante da normalidade dos exames solicitados nas questões 9 e 10, qual seria a sua hipótese diagnóstica? Qual seria sua conduta terapêutica?

.....

.....

.....

.....

Resposta no final do artigo

■ CONCLUSÃO

Cistite intersticial/síndrome da bexiga dolorosa é uma entidade complexa. Representa um desafio ao médico, por ser seu diagnóstico baseado em exclusão de outras patologias. Além disso, é de difícil entendimento ao seu portador, por envolver a fisiologia da micção, mudança de hábitos e de ingestão hídrica e piora da qualidade de vida. Não há uma etiologia definida, e seu tratamento consiste em tentativas de diminuir a morbidade e tentar melhorar o desconforto, pois dificilmente os sintomas regredirão totalmente. Deve haver um bom diálogo entre médico e paciente e uma boa relação de confiança, pois a aceitação da patologia pelo paciente de seu caráter crônico é o que pode levar a uma melhor qualidade de vida ao mesmo.

■ RESPOSTAS ÀS ATIVIDADES E COMENTÁRIOS

Atividade 2

Resposta: **D**

Comentário: Cistite intersticial não tem etiologia ou fisiopatologia definidas.

Atividade 3

Resposta: **A**

Comentário: É sabido que mulheres têm maior possibilidade de adquirir a cistite intersticial.

Atividade 4

Resposta: **C**

Comentário: Infecção do trato urinário pode conferir quadro clínico semelhante ao da cistite intersticial, porém deve ser tratada com antibioticoterapia.

Atividade 5

Resposta: **A**

Comentário: Exames solicitados na suspeita de cistite intersticial não são diagnósticos e sim de exclusão de outras patologias.

Atividade 6

Resposta: **C**

Comentário: Antibioticoterapia é proscria para o tratamento de cistite intersticial.

Atividade 7

Resposta: **D**

Comentário: BCG intravesical é usado para o tratamento de neoplasia vesical. Seu uso para tratamento de cistite intersticial é contraindicado.

Atividade 8

Resposta: **C**

Comentário: Úlceras de Hunner são patognomônicas de cistite intersticial.

Atividade 9

Resposta: Diante do quadro de disúria e alteração de frequência urinária, pode-se iniciar uma investigação com urina tipo 1 e urocultura para avaliar a hipótese de infecção urinária. Apesar de negar hematúria, seria conveniente também o estudo com imagem das vias urinárias (ultrassonografia), uma vez que a paciente é tabagista de longa data e, portanto, pode apresentar um quadro de neoplasia urotelial, e também a avaliação de litíase vesical que apresenta sintomatologia semelhante ao quadro.

Atividade 10

Resposta: A paciente deve ser orientada que devido à ausência de infecção de trato urinário, ausência de litíase urinária e neoplasia urotelial, a investigação deve ser mantida, principalmente devido à manutenção do quadro clínico. Podem ser realizados exames mais específicos como cistoscopia e urodinâmica.

Atividade 11

Resposta: A hipótese diagnóstica para essa paciente seria principalmente cistite intersticial/síndrome da bexiga dolorosa. A conduta inicial deve ser explicar à paciente a fisiologia da micção e do que se trata a referida patologia. Orientar algumas mudanças de hábito, como ingesta hídrica, ritmo miccional diário, certos tipos de alimentos que podem piorar o quadro. Orientar a paciente de que o tratamento é dirigido principalmente para melhora da qualidade de vida e que dificilmente os sintomas desaparecerão totalmente com o tratamento; prescrever inicialmente analgésicos (tratamento de primeira linha). Se estes não melhorarem o quadro, podemos passar para o tratamento de segunda linha com antidepressivos, gabapentina e anti-histamínicos. É importante orientar bem sobre as demais opções terapêuticas.

■ REFERÊNCIAS

1. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. *Neurourol Urodyn.* 2002;187(1):167-78.
2. van de Merwe JP, Nordling J, Bouchelouche P, Bouchelouche K, Cervigni M, Dahi LK, et al. Diagnostic criteria, classification, and nomenclature for painful bladder syndrome/interstitial cystitis: an ESSIC proposal. *Eur Urol* 2008;53(1):60-73.
3. Hanno P, Lin A, Nordling J, Nyberg L, van Ophoven A, Ueda T, et al. Bladder Pain Syndrome Committee of the International Consultation on Incontinence. *Neurourol Urodyn.* 2010;29(1):191-8.
4. Hurst RE. Structure, function, and pathology of proteoglycans and glycosaminoglycans in the urinary tract. *World J Urol.* 1994;12(1):3-10.
5. Keay SK, Szekely Z, Conrads TP, Veenstra T, Barchi J, Zhang C, et al. An antiproliferative factor from interstitial cystitis patient is a frizzled 8 protein-related sialoglycopeptide. *Proc Natl Acad Sci.* 2004 Aug;101(32):11803-8.
6. Warren JW, Diggs C, Brown V, Meyer W, Markowitz S, Greenberg P. Dysuria at onset of interstitial cystitis/painful bladder syndrome in women. *Urology.* 2006 Sep;68(3):477-81.
7. Figueiredo Filho RT, Damião R. Síndrome da Bexiga Dolorosa (cistite intersticial e distúrbios relacionados). *Urologia Brasil.* 2013;1(1):175-81.

8. Tincello D, Walker A. Interstitial cystitis in the UK: results of a questionnaire survey of members of the Interstitial Cystitis Support Group. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2005 Jan;118(1):91-5.
9. Warren JW, Wessellmann U, Morozov V, Langenberg PW. Numbers and types of nonbladder syndromes as risk factors for interstitial cystitis/painful bladder syndrome. *Urology.* 2011 Feb;77(2):313-9.
10. Rodrigues Netto MJB. Cistite intersticial. In: Reis RB, Tridade Filho JCS, Simões FA. *Guia Rápido de Urologia.* São Paulo: SBU; 2012. p. 40-2.
11. Sacomani CAR. Síndrome da bexiga dolorosa/cistite intersticial. In: Reis RB, Zequi SC, Zerati Filho M, editores. *Urologia moderna.* Contagem: Lemar; 2013. p. 658-63.
12. Hanno PM, Erickson D, Moldwin R, Faraday MM; American Urological Association. Diagnosis and treatment of interstitial cystitis/bladder pain syndrome: AUA guideline amendment. *J Urol.* 2015 May;193(5):1545-53.
13. Parsons C. The role of a leaky epithelium and potassium in the generation of bladder symptoms in interstitial cystitis/overactive bladder, urethral syndrome, prostatitis and gynaecological chronic pelvic pain. *BJU Int.* 2011 Feb;107(3):370-5.
14. Vij M, Srikrishna S, Cardozo L. Interstitial Cystitis: diagnosis and management. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2012 Mar;161(1):1-7.
15. Engeler DS, Baranowski AP, Dinis-Oliveira P, Elneil S, Hughes J, Messelink EJ, et al. The 2013 EAU guidelines on chronic pelvic pain: is management of chronic pelvic pain a habit, a philosophy, or a science? 10 years of development. *Eur Urol.* 2013 Sep;64(3):431-9.

Como citar este documento

Facio Junior FN, Vasilceac FA, Gabriotti LFB, Spessoto LCF. Cistite intersticial. In: Sociedade Brasileira de Clínica Médica; Lopes AC, Cipullo JP, Kubiak CAP, organizadores. *PROCLIM Programa de Atualização em Clínica Médica: Ciclo 13.* Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2016. p. 67-79. (Sistema de Educação Continuada a Distância; v. 3).